

Reflexe Tussif

Récepteurs

- RAR : Récepteurs d'Adaptation Rapide } → Fibres Affinées AS
- RAL : Récepteurs d'Adaptation Lente } (myélinisées)
- RCP / Réception } → Fibres Amyélinisées (Fibres C)

$\rightarrow$ Naf Vague (x) $\rightarrow$ Centre de la Tour [Bulle Tour central]

Retinal Spind
 = indolent / reflex

Cortical Spind
 = volitive

{

1] Phase Inspiration : $\text{pH} \uparrow$ $\text{pCO}_2 \downarrow$ $\rightarrow \text{H}^+$

2] Pb_{2+} Compleani: auf hygro $\rightarrow$ fess glatt

$$\text{C}_6\text{H}_6 + \text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{P}_2\text{O}_6$$

3] Pha Expansion: I'' auf k_{spz} $\rightarrow$ erweitert $\rightarrow$ bräut gelte

Virus Effluents

- Nbf l'usage infectieux
- Recurrent
↓
Forme de gélite
- Vague X
- Phases Covid C3-4-5
 - Nbf Éléments
↓
De vaccination / vaccination passives
- Nbf Spécimen Mortel
 - covid 19 p Abdo
= ↑ P. trans.

Trachea 5 Brack

16-20
Anmeane cartilaginea = Rigidität Tracheal

$\sum$ ^{Non-ali}  Pas d'interaction Synapsidipe Terminé

Exocytosis (Secretion) $\rightarrow$ β_2 -Adrenoreceptors $\rightarrow$ Bronchodilation

PE — Acetylcholine — M1 muscarinic receptors — Acetylcholine

M2-M3 Muscarinige $\rightarrow$ Bronchoconstriction

Volume Bronchial Rupture = V_{max}



Volumen nicht
= Bronchokonstriktion H29

Tono $\rho \Sigma$ di base

Resistencia Voles Aeronaves

$$R = \frac{8\eta L}{\pi n^4} \quad \Delta \text{ Regon}$$

Defens Respiratorie

Non-reflexive

- celso vibrate

- Tuberculosis

- monomer = little blocks

- Reflex (= involuntär + unmittelbar)

→ passifs = prévisions : après
bonifications

↳ acido = eliminare, *Terminant* = *Mycoplasma* *hominis*
• *hominis*

- Tox = Systemic Respirator

NEZ

Teacher/leader

VS

Tardif (40:60 ans)

5:20 AM

7. 1. E

15

→ PNE amphib

History / Literature

Polynesian ...

↓
Anthrax allergen = lesions inflammation. Abrasion Epithelium
↓
• \$ mucosa

Théâtre Brechtien TVO

Qui

Riverside

brachidactylus

Qui

Fach, Mithraschloß $\rightarrow$ TVO

03.1

Reinok ←

- Bronchite Chronique

Hyperbaea glomerata & *californica*

Indio Red $> 0,9$ $\frac{\text{Tail Glands}}{\text{Tail Muscles}}$

Mitosis Malpighiana

- Empyema: obstruction paraclyne

$\downarrow$ influence $\rightarrow$ Trop Proteases & Elutase / Pass away Antigenation

E. J. Conner, Arlington

Re: 1-8

Biomechanics

↳ neutrophils →

2

- Asthma

• Bronchiectasis

Dans l'ordre des branches

Location

D. A.

41

Labrador

Taxen/infirmed

Spirometrie en post-bronchodilatatie

→ $P_{ao}/P_{a\bar{o}}$ arterial VEMS

Tv6 Non circuit

Destruction Epithelium / Tissue Bronchi

Empysem → Affected bronch

Name _____

... metaphysi/ kaln

} Pas de retour possible...

Histologie

Conduits nasaux

- Parado-Sinufus
- Gros et 4 branches
- offensif
- respiratoire
- Paro de cils vibr.
- Cils vibratiles
- douches = cils offensifs
- Serron
- Arrière Anaplasme
- Balles offensifs

Pathologie: nasobuccale conduit nasal
= Esthénobuccalisation
Sous KADISH
A: Nasale
B: Nasale + Sinus
C: Nasale + Muc

Trouée

Cartilage Hyalin
fin à char

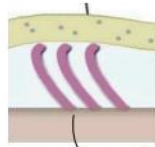
Branch

Arrière
lunette

Branches

Cartilage

Branches Termin
& Dors
↳ Surface
↳ GAG / hyal / c.Ta



Mucus Bronchique

GEL: deshydraté à viscosité élevée
SOL: fluide à faible viscosité

Cils Vibratiles

Arrière na. = 9 doublets MT
+ 2 centra

Corpuscule Basal = 9 triplets MT

Basal

Nocice / Dégéné



Pathologie:

5^o Kartagener: Imperméabilité des organes

Disco-castor: sans à droite

Sclérotie

Alvéole

PT1: alvéole / hématox

Arrière SANG - 4 endothélium
PT1 hématox COMMAN

PT2: corps lamellaires + Microvilli

Surfactant
DPPC = Tension active
Surfactant Protéine A/B/C/D - Immunité Innée!
régule \$ hématox → microvilli

Sarcoidose:

Affet: tissu interstitiel SANS NÉCROSE!

inflammation → TH1
↳ Macrophage

Forme un Granulome

Adhés des fibrocytes!

Nécrose = tubercule

1/3 grains optiques; Small histiocyte cortico-stéroïdes
1/5 fibres minérales

LBA: Lowry Broncho-Alvéolaire

on diag: injection sérum pty → réaction J Analyse

Protéine Alvéolaire

Surfactant Accumulé Alvéole → déficit de Clearance Surfact

Substance lipoprotéiniques (PAS+)

Ø Auto-Immune, adulte, A_c GM-CSF

Pneumocystis Jirovecii

Chromophore opacités → Hyphae PT1 J PT2 + action

≠ Mucosité: affectation mucus bronchique trop épais

Hémoptysie = Toux sanglante

LBA: Sang (<24h)

Erythrocytose = macrophages mangent les GR

Macrophages chargés Hématoxine (3-7%)

Ligament fin = coloré LBA / Bleu de Prusse